

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE DEPRESIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS (CES-D)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Sintomatología Depresiva en Población General y Clínica

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos (CES-D).
Nombre Original (Inglés)	<i>Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D)</i>
Autora Original	Dra. Lenore Sawyer Radloff (1977), National Institute of Mental Health (NIMH), EE. UU.
Adaptaciones Españolas	Soler et al. (1997); Vázquez et al. (2007); Saldivia et al. (2019).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado epidemiológico y clínico de sintomatología afectiva.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 20 reactivos tipo Likert (0 a 3) con 4 ítems redactados en sentido positivo (invertidos).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 14 años). Cribado comunitario, atención primaria e investigación médica.
Tiempo de Administración	4 a 7 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público (documento del gobierno federal de los EE. UU. / NIMH). Libre uso no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO EPIDEMIOLÓGICO

La CES-D fue desarrollada específicamente para la investigación epidemiológica de la depresión en población general, superando las limitaciones de escalas previas concebidas únicamente para poblaciones psiquiátricas graves. El instrumento pone un acento primordial en el **componente afectivo** (ánimo deprimido, desesperanza, soledad) y en la **pérdida de afecto positivo**, permitiendo discriminar gradientes de malestar psicológico en la comunidad.

Desde el punto de vista psicométrico y cognitivo, la inclusión deliberada de 4 reactivos de afecto positivo e interpersonal (ítems 4, 8, 12 y 16) reduce el sesgo de aquiescencia y permite captar la anhedonia como un factor independiente del afecto negativo. Su diseño evalúa la presencia de síntomas durante la última semana, capturando fluctuaciones reactivas a estresores psicosociales recientes y facilitando estudios de prevalencia y monitorización poblacional.

3. ESTRUCTURA FACTORIAL DE 4 FACTORES (RADLOFF, 1977)

Factor Clínico	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Afecto Depresivo	7 ítems	0 a 21	Tristeza (6), desánimo (3), llanto (17), soledad (14), fracaso vital (9), miedo/aprensión (10) y tristeza profunda (18).
2. Afecto Positivo (Invertidos)	4 ítems	0 a 12	Sentirse tan bueno como los demás (4), optimismo hacia el futuro (8), felicidad personal (12) y disfrute de la vida (16).
3. Síntomas Somáticos / Retardo	7 ítems	0 a 21	Molestia por cosas habituales (1), falta de apetito (2), esfuerzo excesivo para todo (7), sueño inquieto (5), fatiga motora (20), problemas de concentración (11) y no poder empezar tareas (13).
4. Dificultad Interpersonal	2 ítems	0 a 6	Percepción de hostilidad ajena / antipatía (15) y sentimiento de rechazo de la gente (19).
PUNTUACIÓN TOTAL	1 al 20	0 a 60	Índice acumulativo global de malestar depresivo epidemiológico.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Elevada consistencia interna: alfa de Cronbach de 0.89 a 0.92 en muestras españolas comunitarias y clínicas (Soler et al., 1997; Vázquez et al., 2007).
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte estándar ≥ 16 : sensibilidad del 87% y especificidad del 82% frente a diagnósticos DSM de Episodio Depresivo Mayor.
Validez Concurrente	Excelente correlación con BDI-II ($r = 0.81$), HAM-D ($r = 0.74$) y escala de depresión de Zung ($r = 0.79$).
Invarianza de Medida	Estructura tetrafactorial replicada sistemáticamente a través de distintos grupos de edad, género y nivel socioeconómico en países de habla hispana.
Rendimiento en Mayores	En adultos mayores (> 65 años), la escala mantiene un rendimiento excelente para detectar depresión geriátrica y soledad.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ÍTEMS

Se valora la frecuencia experimentada durante la **última semana**:

- **0** = Rara vez o nunca (menos de 1 día) | **1** = Algún o poco tiempo (1 a 2 días) | **2** = Una cantidad moderada de tiempo (3 a 4 días) | **3** = La mayor parte o todo el tiempo (5 a 7 días).
- **Inversión de Ítems Positivos:** Los reactivos **4, 8, 12 y 16** deben invertirse obligatoriamente antes de sumar: (0 $\rightarrow$ 3, 1 $\rightarrow$ 2, 2 $\rightarrow$ 1, 3 $\rightarrow$ 0).
- **Puntuación Total CES-D:** Suma directa de los 16 ítems directos más los 4 ítems invertidos (Rango total: **0 a 60 puntos**).

6. ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y PUNTOS DE CORTE (RADLOFF, 1977)

Nivel	Puntuación	Estado Clínico	Conducta Asistencial Recomendada
No Depresivo	0 a 15	Sintomatología dentro de la normalidad	Ausencia de malestar clínicamente relevante. Mantener estilos de vida saludables y autocuidado.
Depresión Leve	16 a 23	Cribado Positivo (Corte ≥ 16)	Presencia de sintomatología afectiva relevante. Sugiere episodio depresivo leve o distimia. Entrevista clínica y seguimiento.
Depresión Mod.	24 a 35	Depresión moderada sintomática	Alta probabilidad de Trastorno Depresivo Mayor. Indicación de psicoterapia formal y/o valoración farmacológica.
Depresión Grave	36 a 60	Depresión severa / incapacitante	Afectación global grave, inhibición o sufrimiento psíquico intenso. Valoración psiquiátrica preferente y cribado de suicidio.

PUNTOS DE CORTE DIFERENCIALES SEGÚN POBLACIÓN: En estudios comunitarios, el umbral de **16 puntos** optimiza la detección epidemiológica. En contextos de pacientes con enfermedades médicas crónicas (dolor crónico, oncología), se recomienda elevar el punto de corte a **≥ 20 o 21 puntos** para evitar falsos positivos derivados de síntomas somáticos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO CLÍNICO Y DETECCIÓN DE ANHEDONIA

INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LOS FACTORES DEL CES-D: • **Déficit de Afecto Positivo (ítems 4, 8, 12, 16):** Puntuaciones invertidas altas (reflejando incapacidad para disfrutar o sentir esperanza) son un fuerte predictor de depresión endógena o melancólica y menor respuesta a psicoterapia breve pasiva. • **Factor Interpersonal (ítems 15 y 19):** Elevación específica indica vivencias de rechazo, hostilidad percibida o aislamiento social, orientando hacia intervenciones de terapia interpersonal (TIP) o entrenamiento en asertividad.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: CRIBADO EN ATENCIÓN COMUNITARIA

Paciente: Varón de 67 años, jubilado reciente, que acude a un centro cívico comunitario por desmotivación general, problemas para conciliar el sueño y sensación de soledad tras el cese laboral. **Puntuación CES-D Total: 27 puntos (Nivel Moderado — Cribado Positivo).** • **Desglose factorial:** Afecto Depresivo = 11/21 (tristeza, desánimo y miedo al futuro); Afecto Positivo (Invertido) = 9/12 (apenas puntúa en disfrute o esperanza); Síntomas Somáticos = 6/21 (sueño interrumpido y cansancio); Interpersonal = 1/6. **Conducta Asistencial:** Se confirma la presencia de un Episodio Depresivo Leve-Moderado reactivo a la transición a la jubilación con pérdida de rol social. Se inicia psicoterapia de grupo focalizada en reconstrucción de proyectos vitales y reincorporación a actividades asociativas comunitarias. A las 8 semanas, el CES-D desciende a 11 puntos (rango normal), recuperando la iniciativa personal y el bienestar subjetivo.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN DEL ÍTEM 18

ALERTA: AUSENCIA DE ÍTEM SUICIDA La CES-D no contiene un ítem específico de ideación autolítica. Puntuaciones totales ≥ 24 obligan al evaluador a explorar verbalmente de forma explícita la presencia de pensamientos de muerte o intencionalidad suicida.

CRITERIO TEMPORAL (1 SEMANA) Dado que evalúa la última semana, no sustituye el criterio DSM de 2 semanas continuadas para diagnóstico formal; funciona como cribado de alta sensibilidad para detección de casos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Radloff, L. S. (1977). The CES-D scale: A self-report depression scale for research in the general population. *Applied Psychological Measurement*, 1(3), 385–401.
2. Soler, J., Pérez-Sola, V., Puigdemont, D., Pérez-Blanco, J., Figueres, M., & Álvarez, E. (1997). Estudio de validación del Center for Epidemiologic Studies-Depression (CES-D) en una población española de pacientes deprimidos. *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*, 25(4), 243–249.
3. Vázquez, F. L., Blanco, V., & López, M. (2007). An adaptation of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale for use in non-professional caregivers. *Psychiatry Research*, 153(3), 257–266.
4. Carleton, R. N., Thibodeau, M. A., Teale, M. J., Welch, P. G., Abrams, M. P., Robinson, T., & Asmundson, G. J. (2013). The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale: a review with a focus on alternative factor structures. *Review of General Psychology*, 17(1), 25–46.